

Amoxicilline

Antibiotiques · 40 spécialité(s) active(s) au registre

RÉSUMÉ EXPRESS

Sous-classe : Aminopénicilline (pénicilline A), sous-groupe des bêta-lactamines. DCI la plus prescrite au monde, inscrite sur la liste OMS des médicaments essentiels (critère « Access » — Watch pour les associations).

Mécanisme d'action : Bactéricide temps-dépendant. Fixation covalente sur les PBP (principalement PBP3 chez les Gram négatif, PBP1 et PBP2 chez les Gram positif), inhibition de la transpeptidation, activation des autolysines bactériennes (N-acétylmuramyl-L-alanine amidase), lyse osmotique. L'amoxicilline est inactivée par les bêta-lactamases staphylococciques (pénicillinases), par les bêta-lactamases à spectre élargi (BLSE) et les AmpC des entérobactéries, par les bêta-lactamases à spectre étendu d'*Haemophilus* et de *Moraxella*.

POSOLOGIE

Adulte : 1 à 3 g/jour per os en 2 à 3 prises (1 g × 3/jour pour angine, pneumonie, sinusite ; 2 g × 2/jour pour infection urinaire, otite). Infections sévères : jusqu'à 6 g/jour IV (3 g × 2/jour) en 4 prises. Prophylaxie endocardite : 2 g per os 60 min avant le geste (dose unique). Endocardite à streptocoque oral : 12 g/jour IV (4 g × 3/jour ou perfusion continue) pendant 4 semaines ± gentamicine les 2 premières semaines. *Helicobacter pylori* : 1 g × 2/jour pendant 7-14 jours en trithérapie. Listériose : 5 g/jour IV (4 prises) pendant 3-4 semaines + gentamicine. Dose maximale : 6 g/jour.

Enfant : 50 à 100 mg/kg/jour per os en 2 à 3 prises (max 3 g/jour). Otite : 80-90 mg/kg/jour en 2 prises. Angine : 50 mg/kg/jour en 2 prises (sans dépasser 1 g × 2/jour). Nourrisson < 3 mois : 30 mg/kg × 2/jour. Suspensions buvables dosées à 125, 250 ou 500 mg/5 mL — pipette doseuse graduée en kg ou en mL.

Durée du traitement : Angine streptococcique : 6 jours (recommandation AFSSAPS/HAS 2011, France — le schéma 6 j à 50 mg/kg/j en 2 prises est validé). Otite : 5 jours chez l'enfant > 2 ans, 8-10 jours chez l'enfant < 2 ans. Pneumonie : 5-7 jours. Sinusite : 7-10 jours. Infection urinaire non compliquée : 5 jours (femmes) ou 7 jours (hommes). Listériose : 3-4 semaines. Endocardite : 2-6 semaines.

Moment de la prise : Pendant ou avant le repas (l'alimentation ne réduit pas significativement l'absorption de l'amoxicilline, à la différence de l'ampicilline). Pour la forme IM : injection profonde quadrant supéro-externe fessier, patient couché.

CONTRE-INDICATIONS

Allergie aux bêta-lactamines (CI absolue), antécédent d'ictère cholestatique ou de maladie sérique aux pénicillines ; mononucléose infectieuse (risque majeur d'éruption maculo-papuleuse, 70-90 % des cas, non allergique — due à l'activation polyclonale des lymphocytes B par le virus EBV et la formation d'anticorps anti-amoxicilline) ; leucémie lymphoïde chronique ; infection à CMV ; traitement concomitant par allopurinol (risque de rash majoré de 3 à 5 fois).

INTERACTIONS CLÉS

Allopurinol : Multiplication par 3 du risque d'éruption cutanée (potentialisation du métabolisme immuno-allergique).

Méthotrexate : Diminution de l'excrétion tubulaire rénale du méthotrexate par compétition OAT, augmentant la toxicité médullaire et hépatique — surveillance étroite, voire contre-indication.

Anticoagulants oraux (AVK — warfarine, acénocoumarol) : Augmentation de l'INR par modification de la flore intestinale productrice de vitamine K, hémorragie possible — surveillance INR et adaptation posologique.

Contraceptifs oraux estroprogestatifs : Baisse d'efficacité théorique (modification de la flore intestinale réduisant le cycle entérohépatique des estrogènes) — méthode complémentaire (préservatif) pendant le traitement et 7 jours après (recommandation ANSM).

GROSSESSE / ALLAITEMENT

Grossesse : Indiqué. L'amoxicilline est l'antibiotique de référence au cours de la grossesse (CRAT : « données humaines nombreuses rassurantes, non tératogène »). Premier choix pour infection urinaire gravidique, angine, listériose gravidique, prophylaxie de l'endocardite au cours du travail.

Allaitement : Indiqué. Passage faible dans le lait (rapport lait/plasma 0,05-0,1), sans toxicité pour le nouveau-né. Risque théorique de diarrhée, candidose, sensibilisation — surveillance des selles de l'enfant allaité.

Précisions : L'amoxicilline est l'antibiotique de choix pour la listériose maternofoetale (5 g/jour IV en 4 prises pendant 3-4 semaines, en association à gentamicine les 7 premiers jours).

CONSEILS AU COMPTOIR — RÈGLES D'OR

Communication au comptoir : « C'est l'antibiotique le plus courant en ville. Prenez-le pendant les repas pour éviter les maux d'estomac, à heures régulières, par exemple 8h-20h pour 2 prises. Respectez bien la durée indiquée, même si vous allez mieux avant. Si vous avez de la diarrhée, buvez beaucoup d'eau et prenez des probiotiques. Prévenez immédiatement votre médecin si vous avez une éruption cutanée ou de la fièvre. »

Mode d'utilisation pratique : Pour la suspension buvable : reconstituer avec de l'eau bouillie refroidie jusqu'au trait de graduation, agiter vigoureusement, vérifier la dose avec la pipette ou la cuillère-mesure fournie, agiter avant chaque prise. Conservation 7-14 jours au réfrigérateur selon le fabricant. Pour le comprimé dispersible : le dissoudre dans un demi-verre d'eau, boire immédiatement, rincer le verre. En cas d'oubli : prendre la dose dès que possible si < 2 h d'écart, sinon sauter la prise et continuer le schéma normal — ne jamais doubler la dose.

Piège classique : Prescription d'amoxicilline chez un patient présentant une mononucléose infectieuse non diagnostiquée — l'éruption maculo-papuleuse est quasi constante (70-90 %) et constitue un piège diagnostique (le patient est souvent étiqueté « allergique à la pénicilline » à tort, à vie). Devant toute angine fébrile avec asthénie, adénopathies cervicales et splénomégalie, demander un MNI-test avant prescription.